

LEILA GASQUES TEIXEIRA QUEIROZ		Engenheira
SINTOMAS / QUEIXAS	Dor no bém / Colesterol / Ca de mama	
MEDICAMENTOS	Plavix	
HORA QUE DORME:	22 - 23:30	HORA QUE ACORDA: 8h
BANHEIRO	3x	
TIPO DE RESPIRAÇÃO	nasal	
PRÁTICA EXERCÍCIO	Todos os dias	
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ:	5	ALMOÇO: 5 LANCHE: 5 JANTAR: 5
IDADE: 63	PESO: 70	IAH: 18.8 MALLAMPATI: 4+ SPO2: 83%
AI: 168		
27/03	m. de uso: 1h	
23	Pressão: 5.8 cmH ₂ O	
	Fuga = 3, 7	
	IAH = 0.4. Jua	
15/06 - Retomou uso - CPAP Elite		
17/07	23 - P = 5.8 cmH ₂ O - m. de uso: 30 d.	
	IAH = 0.5 e/h - refere mg "vazado" / "pouco lig" ??	
	m. de uso: 6h40' - lig CPAP Elite → OK no momento. Sima	
04/09	23 - Desceu o Air Mini - Jua	
16/10	23 - P = 5.8 cmH ₂ O - Início o uso do CPAP - Jua.	
17/12	24 - P = 5.8 cmH ₂ O - IAH = 1.2 e/h - m. de uso: 6h40' - Jua	
	P = 5.8 cmH ₂ O - IAH = 1.2 e/h - Fuga = 21. Jua	

Nome: LEILA GASQUES TEIXEIRA QUEIROZ

Sexo: F

Peso: 71.0 Kg

Exame: 33235029

ID: 3381992

Idade: 63 anos

Altura: 168.0 cm

IMC: 25.2 Kg/m²

Atendimento: 18154903

Data: 22/01/2023

Médico solicitante: Dr(a). FABIANA GOULART MARCONDES BRAGA

Laudo de polissonografia: resultado

O exame foi iniciado às 23:02:10 horas e finalizado às 06:01:28 horas. A **latência para o início do sono** foi de 34.2 minutos e a **latência para o início sono REM**, de 255.0 minutos. O **tempo total de sono (TTS)** foi de 354.0 minutos, com **eficiência do sono** de 84.4%. A distribuição dos estágios do sono mostrou 2.4% de **estágio N1**, 62.9% de **estágio N2**, 27.5% de **estágio N3** e 7.2% de **sono REM**. O **tempo de vigília após o adormecer** foi 31.1 minutos. Ocorreram 46 **despertares**, uma média de 7.8 por hora. O **índice de movimentos periódicos de membros durante o sono (PLMS – periodic limb movements in sleep)** foi de 0.0 por hora, sendo 0.0 PLMS por hora **associados a despertares**.

O número total de eventos respiratórios foi de 5, sendo 0 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 5 hipopneias obstrutivas, 0 hipopneias centrais e 0 despertares associados a esforço respiratório (RERA – respiratory effort-related arousal). O **índice de distúrbio respiratório (IDR)** foi de 0.8 por hora e o **índice de apneia/hipopneia (IAH)**, de 0.8 por hora. O **índice de apneia/hipopneia obstrutiva (IAHO)** foi de 0.80 por hora e o **índice de apneia/hipopneia central (IAHC)**, de 0.00 por hora.

A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) **basal** foi de 98%; a **média**, 95% e a **mínima**, 89%. O **índice de dessaturação** foi de 0.0 por hora durante o sono REM e 1.3 por hora durante o sono NREM. A saturação permaneceu abaixo de 90% por 0.0% do tempo total de registro.

Índice de distúrbio respiratório (IDR) = índice de apneias + hipopneias + RERA

Nome: LEILA GASQUES TEIXEIRA QUEIROZ

Data de Nascimento: 9-5-1959

IMC: 24,80

Sexo: Feminino

Data do exame: 06-07-2022

Peso: 70 kg

Altura: 1,68 m

Médico: DRA. FABIANA GOULART

MARCONDES BRAGA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 06-07-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 466,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 46,0 e 124,0 minutos. O tempo total de sono foi de 360,5, eficiência de 77,3% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,2%; estágio N2: 59,2%; estágio N3: 18,3%; sono REM: 20,2%. O índice de despertares foi de 9,0/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 18,8/hora, sendo elas 44 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 48 hipopnéias. A SpO2 média foi de 94% e mínima de 83%, permanecendo 0,7% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 59 - 87 bpm e NREM de 59 - 82 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (9), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 18,8/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (mín. SaO2=83%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. número de despertares breves normal;
7. registro de ronco leve durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau moderado.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM